

Hospiits on koht surmani elamiseks, mitte suremiseks



Regina Lind

ajakiri Sotsiaaltöö

Tallinna Diakooniahaigla hospiitsiteenuse pakkujad tegevusterapeut **Hanna-Stiina Heinmets**, arst ja haigla juht **Jelena Leibur** ning sotsiaaltöötaja **Anu Varep** arutavad ajakirja Sotsiaaltöö toimetajaga, kuidas peaks inimest toetama tema elu viimses järgus. Päev enne meie kohtumist osalesid nad palju mõtteainet andnud koolitusel, kus jagas oma kogemusi 30aastase hospiitsiõe staažiga Barbara von Normann-Coleman.

Mida tähendab hospiitsiteenus ja kuidas seda iseloomustate?

Hanna-Stiina Heinmets: Sageli mõeldakse, et hospiits on asutus, kuhu läheb elu lõpul toetust vajav inimene. Tegelikult on hospiits filosoofia ja seda saab rakendada ükskõik kus: osakonnas, asutuses või kodus.

Jelena Leibur: Hospiits ei ole koht suremiseks, see on koht, kus toetatakse elamist kuni surmani. Surm on üks hetk. Keegi meist ei pääse sellest.

Hanna-Stiina Heinmets: Suri ja ei tohiks ükski jääda, oluline on, et tema juures oleks mõni lähedane või inimene, kes teda toetab.

Jelena Leibur: Ükskõik, kas inimene sureb kodus või haiglas, ta ei tohiks surra üksikuisel nurgas. Selle hetkeni tuleb tal aidata väärikalt elada.

Anu Varep: Hospiits nõuab mõtteviisi muutust.

Kuidas te inimesi toetate?

Anu Varep: Mõni inimene jõuab siia teadmata, kuhu ta tuleb. Võib-olla on ta just saanud arstide konsiliumi lootusetu otsuse. Siis tuleb aidata tal tema tundeid läbi elada. Lihtsam on, kui inimene teab, mis temaga toimub ja on sellega leppinud. Arvatakse, et hospiits on koht surijatele. Veel ei ole harjutud mõtlema, et elukvaliteet peab olema võimalikult hea ka elu lõpus. Hospiitsis aitame elu niimoodi lõpuni elada, et see oleks väärtuslik.

Jelena Leibur: Täna käis meil ühe lahkunu tütar. Tal oli hea meel, et isa sai siin aias käia ja võimelda. Manitsesime tema isa, kui ta üle pingutas ja oli päris väsinud, koormust vähendama, aga mees vastas: „Ah, mis koormus, ma olen eluaeg trenni teinud.” Tema seisund oleks võimaldanud vahepeal isegi koju minna, aga mees ütles, et tal on siin turvaline, sest ta ei tea, millal jälle halvem hakkab. Ühele naisele jälle meeldis aias suitsu teha. Meie ei keelanud, lõpusirgel oli jät ei kasvata ümber. Inimesele oli suits see miski, mis veel naudingut pakkus, võib-olla ainus asi, mis sundis voodist üles tõusma. Ta arvestas teistega,

läks alati kaugemale, et kedagi mitte häirida. Toetasime teda selles lõpuni.

Hanna-Stiina Heinmets: Kõige olulisem, mida lähedastelt oleme tagasisidena kuulnud, on see, et inimestele jäävad meelde need töötajad, kes kuulasid, puudutasid, kallistasid ja naeratasid.

Anu Varep: Emotsionaalsus ja puudutamine ei ole ehk eestlasele loomumane, aga siin on see oluline. Meil on väga häid ja südamlikke töötajaid, kes julgevad puudutada.

Kes meeskonda kuuluvad?

Jelena Leibur: Õde on patsiendi kõrval, ta jälgib sümptomeid ja aitab. Hooldaja on nii lähedal, kui üldse olla saab. Ka arst, sotsiaaltöötaja, hingehoidja kuuluvad põhimeeskonda. Mõnikord on vaja füsioterapeuti, kes võimleks liigesed lahti, või tegevusterapeuti, kes õpetab näiteks, kuidas teist kätt kasutada, kui üks kehapool ei tööta. Meeskonda võib kaasata eriarste, toitumisenõustajaid jt. Ükski pikaajalist hooldust pakkuv asutus ei suuda korraldada hospiitsiteenust ilma vajaliku koolituseta. Oma osakonnas oleme töötajaid koolitanud, enamus on õiget hoiakut ka Norras õppinud.

Hanna-Stiina Heinmets: Meil on hea meeskonnatöö. Väga tähtis on, et saad koos teistega kõik keerulised olukorrad lahti harutada.

Jelena Leibur: Meeskonnatöö tähtsus ei mahugi sõnadesse. Teadmine, et saan usalda patsiendid oma töötajate hoolde ja info on alati adekvaatne. Samuti on väga tähtis hea koostöö kolleegidega teistest asutustest. Hea näide on PERHi palliatiivse ravi osakond, mida veab dr Pille Sillaste. Seal on õed, sotsiaaltöötajad, psühholoog, hingehoidjad. Meeskonda juhib arst ja kõik teised tulevad temaga kaasa. Meil on väga hea koostöö.

Kas pakute teenust ka kodudes?

Jelena Leibur: Väga vähe. Meil ei ole selleks veel süsteemi. Et kodudes seda teenust osutada peab teenust saaval inimesel olema koht, kuhu saab ööpäev läbi helistada ja abi saada.

Hanna-Stiina Heinmets: Ameerikas sureb Barbara von Normann-Colemani sõnade kohaselt 90% inimesi kodus. Toetatakse seda, et inimene võiks surra ja vajalikku abi saada oma kodu seinte vahel. Barbara rääkis, et algul käis ta uut patsienti vaatamas kord nädalas, ja kui vajadus suurenes, siis kas või mitu korda päevas.

Anu Varep: Neid toetavad ka vabatahtlikud. Meil on tavaline, et koduõde käib üks kuni kolm korda nädalas.

Jelena Leibur: Koduõde saaks käia ka iga päev, kuid tema visiit kestab 1,5 tundi, sellesse peavad mahtuma ka tulek, minek ja kirjatöö. Vaja on meeskonda, kes toetaks inimest ja tema lähedasi. Kokkuvõttes on sellised koduviisiidid aga ikkagi odavamad kui hooldusasutuste ülalpidamine.

Anu Varep: Arvan, et suhtumine surma on Ameerikas teistsugune, kui meil. Meil on surm veel tabu.

Inimesed ei ole valmis surmast rääkima?

Anu Varep: Olen esimese kursuse sotsiaaltöö üliõpilastel palunud kirjutada tahvlile surmaga seostuvaid märksõnu. Valdavalt on sõnad, mida pakutakse, seotud negatiivsete tunnetega – ikka pisarad või kurbus. Võtab aega, et oma tundeid ja kogemusi avada. Kasvav põlvkond on üsna kinnine. Aga sellest kõik algabki – kuidas mõistame surma ja kas julgeme sellest rääkida.

Jelena Leibur: Me ei räägi isegi vananemisest. Oleme igavesti noored ja ilusad.

Anu Varep: Surma teemat peaks kindlasti käsitlema nii sotsiaaltöötajate kui hooldustöötajate õppekavades. Kui ise kardad, siis ei

oska lähedasi nõustada. Suri ja pigem tahab rääkida, ka keerulistest peresuhetest ja lähendamata asjadest. Kui peres on kõik selgeks räägitud, siis on suremine ilus. Samas oleme näinud olukordi, kus ei tohi midagi öelda ei emale, isale ega õele. Siis on minejal raske. Mäletan patsienti, kes tahtis väga oma pojaga kohtuda, aga poeg oli Soomes. Ta suri pärast seda, kui poja rääkida sai.

Puuduta, naerata, räägi lahkelt ja kuula hoolega. Kümme minutit jäägitut tähelepanu ja sa näitad sellega, et hoolid.

Jelena Leibur: Barbara rääkis, et surijal tuleb lubada minna. Olen samuti soovitanud, et öelge oma abikaasale, et te tulete toime, kui ta läheb. Ärgu ta muretsegu teie pärast. Kuid olen kuulnud ka veenmist: „Sa pead võitlema, terveks saama. Kellele sa meid jätad?” Seda on valus kuulata, kui inimesel ei ole enam jõudu jääda, kuid ta ei julge ka minna. Kui luba on antud, siis saabub rahu.

Anu Varep: Kardetakse, et tõsine jutuajamine tekitab emotsioone.

Hanna-Stiina Heinmets: Meeskond saab inimesi suhtlemisel toetada. Kui inimene ei julge oma lähedasele öelda, mida ta tunneb, siis võib kirjutada näiteks kirja ja töötaja loeb selle ette. Suhelda saab ka e-kirja või Skype'i teel.

Jelena Leibur: Üks juhtum jääb eluks ajaks meelde. Tanel Ots oli meil pastoriks. Üks mees tahtis temaga arutada, mis edasi saab, aga tema naine ei lasknud, öeldes ikka, et surmast on vara rääkida. Pastor oli nende juures. See mees vaatas Taneli poole ja ütles siis naisele: „Sina oled nüüd vait ja mina räägin pastoriga surmast.” Ta oli enda jaoks kõik läbi mõelnud. Kui palju kergem tal olnuks, kui naine oleks olnud mõistev ja lasknud tal rääkida.

Toetust vajavad ka lahkuvate inimeste lähedased.

Jelena Leibur: Korraldame igal aastal oktoobris hospiitspäeva, kuhu kutsume lahkunute omaksed. On teenistus, kontsert ja kohvijoomine. Mälestame koos lahkunuid. Selline üritus on inimestele vajalik, nad ütlevad, et see on neid aidanud.

Anu Varep: Lähedastel võtab kaotusest üle saamine aega ja ka sel ajal on neile vaja tugisüsteemi.

Hanna-Stiina Heinmets: Barbara rääkis, et ka tema kogenud hospiitsiõena vajas väga tugigruppi, kui suri ta ema ja aasta hiljem abikaasa. Lähedastele on väga vajalik ka hingehoid, eriti valus on kaotada lapse.

Kuidas annaks hospiitsi põhimõtteid sobitada hoolekandeesutuste ja haiglate suure töökoormusega?

Hanna-Stiina Heinmets: Ka siis, kui sul on inimese jaoks ainult kümme minutit, saad rakendada hospiitsifilosoofia põhimõtteid. Puuduta, naerata, räägi lahkelt ja kuula hoolega. Kümme minutit jäägitut tähelepanu ja sa näitad sellega, et hoolid.

Anu Varep: Lihtsad asjad algavad sinust endast.

Jelena Leibur: Muidugi võiks olla rohkem personali ja aega ühe haige kohta. Meil on arst-konsultant terve maja peale. Ja kui 12 haige kohta on üks õde, siis ka tema ei jõua igale poole. Kõik teame tunnet: ei jõudnud, ei rääkinud, nüüd ta lahkus ja on juba hilja.

Hanna-Stiina Heinmets: Meditsiini mentaliteet on ülesandepõhine – suhtleme vähe ja tuli on pidevalt takus. Kui olen patsiendi juures ja räägin terve tunni, siis kohtab ka suhtumist, et sa pole midagi teinud, ainult rääkisid.

Jelena Leibur: Üks hingehoidja kõneles, kui raske oli tal oma aruandesse kirjutada, mitme inimesega ja kui kaua ta oli vestelnud. See tapab suhtluse juba eos.

Kas ootate hospiitsi vabatahtlike, kes aitaksid lünki täita?

Jelena Leibur: Suri ja ei peaks olema ükski, aga Eestis ta tihti ikkagi on. Püüame, mis me suudame, aga mõnikord tuleb see hetk ikka siis, kui inimese kõrval pole kedagi, kes kätt hoiaks. Soomes ja Norras aitavad vabatahtlikud. Ka meil võiks nii olla. Üks oleks lahkujaga paar tundi, siis teine. Aga see eeldab rohkem inimesi ja koolitust.

Anu Varep: Meil on olnud tublisid vabatahtlikke, aga kahjuks tuleb noori vähe peale.

Hanna-Stiina Heinmets: Inimesed mõtlevad ja tahavad head, aga kõike ei jõua. Pike-maajalisi vabatahtlikke on vähe. Mõnikord jõuavad inimesed siia oma kogemuse kaudu, kui midagi rasket elus juhtub. Vabatahtlike koordineerimine on omaette töö – nendega peab leidma aega vestelda, et anda tagasisidet ja tunnustust.

Korraldate 16. novembril rahvusvahelise hospiitsikonverentsi. Mis on selle teema?

Jelena Leibur: Tänavuse konverentsi korraldab MTÜ Pallium, Põhja-Eesti Regio-

naalhaigla võimaldab kasutada oma saali. Teema on „Palliativne ravi Eestis – kas ainult unistus?”. Belgia, Läti, Ameerika, Tšehhi, Soome ja Eesti esindajad tutvustavad oma maa palliativravi arengut.

MTÜ Pallium liikmed on seisukohal, et ka Eesti vajab palliativse ravi kontseptsiooni, mis ei oleks suunatud ainult vähihaigetele, vaid hõlmaks kogu tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi. Hospiits on selle osa. Inimesed on kodudes perearsti hoole alla, onkolooge ja valuarste ei jagu. Igas perearstikeskuses peaks olema koolitatud spetsialist, kes teemat valdab.

Ootame sotsiaalministeeriumilt selget ülesandepüstitust, sest ka entusiastid väsivad ära, kui riik ei tule järele. Kutsume kõiki, kes on huvitatud palliativse ravi arengust, MTÜ Pallium liikmeks.

Hanna-Stiina Heinmets: Meil on palju toredaid tegutsejaid, kes soovivad elu paremaks muuta, kuid süsteem seda alati ei toeta. Annaks Jumal meile jaksu, et motivatsioon ei lõpeks. Õnneks on meie hea meeskond seni tuju üleval hoidnud. Koostöö annab kindlustunnet, et oled õigel teel. **S**

SA EELK Diakooniahaigla hospiitsosakond, mis avas uksed 2002. a sügisel, on esimene hospiits Eestis. Osakonnas on kohti 12 patsiendile. Hospiitsiteenust pakuvad ka SA Tartu Ülikooli Kliinikum (7 kohta) ja Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliinik (10 kohta). Vt lähemalt: www.pallium.ee